

МАСТЕР-ПАСПОРТ ПАЦИЕНТА

Иксодовый клещевой боррелиоз (А69.2). Повторный приём
22.09.2026

Атрибут документа	Значение
Тип документа	Мастер-паспорт клинического случая (самодостаточный)
Версия	v1.4
actualityDate	22.09.2026
Предыдущие версии	v1.0 (первичный приём) → v1.1 (Доп.№1) → v1.2 (Доп.№2) → v1.3 (Доп. №3) → v1.4 (Доп.№4, текущая)
Основание версии	Закрытие дифдиагноза по эритеме (ответы п.8 Доп.№3)
Назначение	Принести на следующий приём. Документ заменяет все предыдущие — читать только его
Следующая обязательная точка	Очный контроль 02–06.10.2026 (день 10–14 терапии)
Статус случая	● Активная инфекция, терапия начата 22.09.2026

 **Правило работы с документом:** фиксируется **только подтверждённое**.
Неподтверждённые/расчётные данные помечены ``. Пустые поля — для заполнения к следующему приёму.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ

Поле	Значение
ФИО	Позолотина Мария Борисовна
Дата рождения / возраст	21.07.1978 / 48 лет
Пол	женский
ID лаборатории	1958-000124
Лаборатория	Genesis
Регион	Краснодарский край
Направивший врач	не установлен (самообращение)

РАЗДЕЛ 2. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ (таймлайн)

№	Дата	Событие	Статус данных
1	~21.07.2026 ``	Присасывание клеща. Локализация: внутренняя поверхность верхней трети бедра	Расчётно (от «55–56 дней» на первичном приёме)
2	~28.07.2026 ``	7-й день: появление эритемы в месте присасывания. Размер 20×10 см	Подтверждено пациенткой
3	1-я неделя после эритемы	Выраженная слабость	Подтверждено
4	Первые 2 недели	Интенсивная головная боль	Подтверждено
5	Тот же период	Дебют артралгий голеностопных суставов (одновременно с эритемой)	Подтверждено
6	~04–11.08.2026	Клотримазол местно, 7 дней (самолечение, через 2 нед. после укуса) — без эффекта , эритема продолжила рост	Подтверждено
7	После укуса ``	Появление одышки при умеренной нагрузке (de novo)	Подтверждено
8	~15–16.09.2026	Первичный приём инфекциониста. Заключение: «всё хорошо, антибиотики не нужны». Обследование не назначено	Подтверждено
9	17.09.2026	Самостоятельная сдача анализов (ОАК, биохимия, серология)	Подтверждено
10	20.09.2026	Появление 3 мелких бессимптомных точек на запястье	Подтверждено
11	22.09.2026	Повторный приём. Диагноз верифицирован. Старт доксициклина	Текущая точка
12	12.10.2026	Плановое окончание курса	План

Срок от присасывания на 22.09.2026: ≈ 63 дня (9 недель). Длительность существования эритемы на 22.09.2026: ≈ 8 недель, разрешения не было.

РАЗДЕЛ 3. СТАТУС НА 22.09.2026

3.1. Мигрирующая эритема — ключевой очаг

Параметр	Значение	Флаг
Локализация	Внутренняя поверхность верхней трети бедра ``	—

Параметр	Значение	Флаг
Совпадение с местом присасывания	Да	✓
Размер исходный (день 7)	20 × 10 см	—
Размер на 22.09.2026	~22 × 11 см (+10 %)	●
Динамика	Непрерывный рост, периодов уменьшения не было	●
Направление роста	Эксцентрически, в одну сторону	✓ типично
Центральное просветление	Есть (центр светлее)	✓ патогномонично
Валик по краю	Нет	✓ против микоза
Шелушение	Было на фоне клотримазола, сейчас нет	✓
Зуд / жжение / боль	Нет (бессимптомна)	✓ типично для МЭ
Локальная гипертермия	Да, кожа горячее окружающей	● активное воспаление
Реакция на клотримазол (7 дней)	Эффекта нет, рост продолжился	✓ микоз исключён
Разметка маркером	Выполнена 22.09.2026	✓
Фотофиксация с линейкой	Выполнена 22.09.2026	✓

3.2. Системные и органные проявления

Система	Статус	Детализация
Суставы	● Артралгии, синовита нет	Голеностопные, симметрично , только боль утром, скованность 2 мин , повтор в обед, не мигрируют , дебют одновременно с эритемой . Припухлости/отёка/покраснения нет
Сердце / дыхание	● Одышка при умеренной нагрузке	Порог — быстрый шаг. Появилась после укуса. Сердцебиения, перебоев, «замираний», головокружения нет . Отёков голеней, ортопноэ, ночной одышки нет
Нервная система	● Анамнестически	Интенсивная ГБ 2 недели в острый период. Текущих жалоб нет. Невролог не осмотрен
Кожа (вторичное)	● Незначимо	3 мелкие бессимптомные точки на запястье от 20.09, не растут, самоисчезают, только на запястье, без контакта с новым
ЖКТ / гепатобилиарная	● Сопутствующий трек	Тяжесть в правом подреберье. ЖКБ, хр. калькулёзный холецистит вне обострения

Система	Статус	Детализация
Лихорадка	Нет	—

3.3. Аллергологический и фармакологический анамнез

Параметр	Значение
Аллергия на тетрациклины / пенициллины / цефалоспорины	Нет
Беременность / лактация / планирование	Нет
Контрацепция	ВМС Мирена — взаимодействия с доксициклином нет , надёжность не снижается
Болезни пищевода, ГЭРБ, эрозии	Нет
Фотосенсибилизация в анамнезе	Нет
ЭБВ / ЦМВ / сифилис / аутоиммунные	Нет → перекрёстные реакции маловероятны
Прежние укусы клещей	Нет → «фоновая» серопозитивность исключена
Курение, болезни сердца/лёгких, анемия в анамнезе	Нет
Постоянные препараты (ИПП, антациды, Fe, Ca, Mg, варфарин, ретиноиды)	Нет

РАЗДЕЛ 4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ (забор 17.09.2026)

4.1. Серология — ключевой блок

Показатель	Результат	Референс	Флаг
anti- <i>B. burgdorferi</i> IgG (полукол.)	1,6 КП	<1,0 отриц. / >1,0 полож.	ПОЛОЖИТЕЛЬНО
anti- <i>B. burgdorferi</i> IgM (кач.)	сомнительно	—	серая зона (норма для 9-й недели)
Иммуноблот IgG/IgM	НЕ ВЫПОЛНЕН	—	долг

4.2. Общий анализ крови (17.09, 08:51)

Показатель	Результат	Референс	Флаг
Эритроциты	5,51 ×10 ¹² /л	3,5–5,2	↑

Показатель	Результат	Референс	Флаг
Гемоглобин	151 г/л	117–160	норма (верх)
Цветной показатель	0,82	0,85–1,05	● ↓
Гематокрит	46,8 %	35–47	● верх. граница
MCV / MCH / MCHC	85 / 27,3 / 32,3	норма	—
Лейкоциты	6,13 ×10 ⁹ /л	4–10	норма
Нейтрофилы (п/я / с/я)	48 % (1 / 47)	47–72	норма
Лимфоциты % / абс.	42 % / 2,57	19–37 / 1–4,8	● отн. ↑, абс. норма
Моноциты / Эозинофилы / Базофилы	4 / 5 / 1 %	норма	—
Тромбоциты	385 ×10 ⁹ /л	180–320	● ↑
MPV / PCT	9,9 фл / 0,38 %	норма	—
СОЭ (Вестергрен)	3 мм/ч	2–20	норма

4.3. Биохимия

Показатель	Результат	Референс	Флаг
СРБ	3,26 мг/л	<5	норма
АСТ / АЛТ	19,72 / 29,92 Ед/л	0–31 / 0–34	норма
Билирубин общий / прямой	4,62 / 1,76 мкмоль/л	2–21 / 0–5,13	норма
Креатинин	64–65,42 мкмоль/л	44–80	норма
СКФ	98,68 мл/мин/1,73м ²	>60	норма
ГГТП / ЩФ	НЕ ВЫПОЛНЕНЫ	—	■ долг

4.4. Что исключено по лабораторным данным

Исключено	Основание
Коинфекция анаплазмозом / эрлихиозом	Нет цитопений; тромбоциты повышены , лейкоциты норма
Активное системное воспаление, целлюлит, рожа	СРБ 3,26 + СОЭ 3 + Лейк. 6,13
Боррелиозный гепатит, холестаз	АЛТ/АСТ/билирубин норма (неполно — нет ГГТП/ЩФ)
Обострение холецистита, механическая желтуха	Билирубин, лейкоциты, СОЭ, СРБ норма
Анемия как причина одышки	Hb 151

Исключено	Основание
Почечная недостаточность	СКФ 98,68 → коррекция доз не нужна

РАЗДЕЛ 5. ДИАГНОЗ (актуален на 22.09.2026)

Основной: A69.2

Иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), эритемная форма, ранняя диссеминированная стадия. Персистирующая мигрирующая эритема внутренней поверхности верхней трети бедра (в месте присасывания клеща), длительность ≈ 8 недель, размер ~22×11 см, с центральным просветлением, локальной гипертермией и продолжающимся эксцентрическим ростом. Серопозитивный: anti-B. burgdorferi IgG 1,6 КП (+); IgM — сомнительно. Артралгии голеностопных суставов без синовита. Одышка при умеренной нагрузке — генез уточняется. Этиотропная терапия до 22.09.2026 не проводилась.

Сопутствующие

ЖКБ, хронический калькулёзный холецистит вне обострения. Реактивный тромбоцитоз (385). Подозрение на латентный железодефицит (ЦП 0,82 при эритроцитозе).

5.1. Обоснование (для любого врача, читающего документ)

Полный клинический набор критериев ИКБ:

- 1. Факт присасывания клеща, эндемичный регион;
- 2. Эритема **в месте присасывания**, дебют на **7-й день**;
- 3. Размер **>5 см** (22×11 см);
- 4. **Центральное просветление, эксцентрический рост, бессимптомность, локальная гипертермия**;
- 5. **Сероконверсия IgG** у нелеченого пациента на 9-й неделе — закономерна и ожидаема;
- 6. Системные проявления острого периода (ГБ 2 нед., слабость) и персистирующие артралгии.

5.2. Дифференциальный диагноз — ЗАКРЫТ

Версия	Статус	Решающий аргумент
Мигрирующая эритема (ИКБ)	ПОДТВЕРЖДЕНА	См. п.5.1
Tinea corporis (дерматомикоз)	Исключён	Клотримазол 7 дней без эффекта + нет валика + нет зуда
Кольцевидная гранулёма	Исключена	Нет папулёзного валика, размер, связь с укусом
Эритема Дарье	Исключена	Одиночный элемент, связь с укусом, IgG+

Версия	Статус	Решающий аргумент
Целлюлит / рожа	✅ Исключены	Нет боли, лихорадки, отёка; СРБ/СОЭ/лейкоциты норма
АСА (акродерматит)	✅ Исключён	Срок мал, нет атрофии/синюшности, локализация не дистальная
Токсико-аллергическая реакция на укус	✅ Исключена	Длительность 8 недель, рост, IgG+

РАЗДЕЛ 6. НАЗНАЧЕННАЯ ТЕРАПИЯ

Параметр	Значение
Препарат	Доксициклина моногидрат 100 мг
Режим	по 1 капсуле 2 раза в сутки , интервал ~12 ч
Курс	21 день
Даты	старт 22.09.2026 → окончание 12.10.2026
Первая доза	принята в кабинете 22.09.2026
Обоснование 21 дня	Ранняя диссеминированная стадия по срокам + персистирующая растущая МЭ + системные проявления. Сокращение курса исключено
Обоснование выбора	Перекрывает возможные анаплазмоз/риккетсиозы; пероральная форма предпочтительна при ЖКБ
Клотримазол	ОТМЕНЁН. Никаких мазей/кремов/йода/спирта на очаг

6.1. Почему НЕ цефтриаксон

При ЖКБ цефтриаксон способен провоцировать желчный сладж и «псевдолитиаз» вплоть до билиарной колики. В/в терапия зарезервирована **только** для: подтверждённого нейроборрелиоза с менингитом, АВ-блокады высокой степени, миокардита.

6.2. Альтернативы (при непереносимости)

Препарат	Схема
Амоксициллин	500 мг × 3 р/сут, 21 день
Цефуроксим аксетил	500 мг × 2 р/сут, 21 день
Азитромицин	резерв, эффективность ниже

6.3. Правила приёма (обязательны)

Правило	Причина
Принимать стоя/сидя , полный стакан воды, не ложиться 30–60 мин	Профилактика эзофагита
Разнос с молочным, Са, Fe, Mg, антацидами — 2–3 часа	Хелатирование, падение всасывания
SPF 50 , избегать активного солнца	Фототоксичность (юг России)
Алкоголь исключить	Нагрузка на печень и ЖКТ
Курс допить полностью , даже при исчезновении всех жалоб	Недолеченность → поздние формы
При планировании беременности — сообщить немедленно	Замена на амоксициллин
Уход за очагом (паховая складка)	Хлопковое бельё, минимум трения, сухость, без окклюзии

6.4. Реакция Яриша–Герксгеймера — ОЖИДАЕМА

В первые **24–48 ч**: эритема может ярко покраснеть, стать горячее, слегка расшириться; возможны озноб, температура, слабость, усиление болей в голеностопах. **Это гибель боррелий, а не ухудшение и не аллергия. Терапию НЕ прерывать.** Отмена и немедленный звонок — **только** при: крапивнице по телу, отёке лица/губ/языка, затруднении дыхания.

РАЗДЕЛ 7. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ — СТАТУСЫ

7.1. Выполнено

№	Исследование	Дата	Результат
1	ИФА IgM + IgG к <i>B. burgdorferi</i>	17.09.2026	IgG 1,6 КП (+), IgM сомнит.
2	ОАК + лейкоформула + СОЭ	17.09.2026	См. 4.2
3	Биохимия (базовая)	17.09.2026	См. 4.3
4	Креатинин + СКФ	18.09.2026	64 / 98,68
5	Разметка + фото эритемы	22.09.2026	Исходная точка отсчёта

7.2. Назначено — к следующему приёму

№	Исследование	Срок	Приоритет	Что закрывает	Статус
1	ЭКГ 12 отв. с цифрой PQ , распечатка	22.09		Бессимптомная АВ-блокада — единственный незакрытый острый риск	

№	Исследование	Срок	Приоритет	Что закрывает	Статус
2	Тропонин I (в/ч) + NT-proBNP	23– 25.09	●	Миокардит / Лайм-кардит	
3	Ферритин, железо, ОЖСС, НТЖ	23– 25.09	●	Латентный железодефицит (версия № 1 по одышке)	
4	ТТГ	23– 25.09	●	Тиреоидная причина одышки	
5	ГГТП + ЩФ	23– 25.09	●	Долг; правое подреберье, холестаз	
6	Эхо-КГ	до 25.09	●	ФВ, гипокинез, перикардальный выпот	
7	УЗИ ОБП (печень, ЖП, холедох)	до 29.09	●	ЖКБ, правое подреберье	
8	Иммуноблот IgG + IgM	эта неделя	●	Полнота 2-этапного алгоритма (на тактику не влияет)	
9	Осмотр невролога	до 06.10	●	ЧМН (VII пара), менингеальные знаки, парестезии	
10	Фотоконтроль эритемы каждые 3–4 дня	весь курс	●	Объективный маркер эффективности	
11	Контрольный контакт день 5–7	27– 29.09	●	Рост остановлен?	
12	ОАК + АЛТ/АСТ (переносимость)	02– 06.10	●	Контроль на фоне терапии	

7.3. Условные / резервные (только при показаниях)

Исследование	Триггер назначения
Холтер-ЭКГ 24 ч	PQ >200 мс или сохранение одышки к дню 14
Кардиолог	Любое отклонение ЭКГ / Эхо-КГ / тропонина
РФ, АЦЦП, моченая кислота, АСЛ-О	Появление объективного синовита на осмотре
УЗИ голеностопного сустава	Выявление выпота
Биопсия края эритемы + ПЦР биоптата	Отсутствие регресса эритемы к дню 14
Кальций крови + Rg ОГК	Сохранение симметричных артралгий через 4 нед. после курса (искл. саркоидоз)

Исследование	Триггер назначения
Спирометрия	Одышка сохраняется при чистых ЭКГ/Эхо/ферритине/ТТГ
Люмбальная пункция	Только при неврологических находках на осмотре

7.4. СНЯТО с плана ✗

Что	Почему снято
Соскоб на грибы (КОН-тест)	Микоз исключён (нет валика, нет зуда, клотримазол без эффекта)
Консультация дерматолога	Дифдиагноз закрыт
Д-димер / поиск ТЭЛА	Нет внезапности, тахикардии; Мирена тромбориск не повышает

РАЗДЕЛ 8. ПОРОГИ ЭСКАЛАЦИИ ПО ЭКГ

PQ(PR) / находка	Тактика
< 200 мс, синусовый ритм	● Амбулаторно, доксициклин 21 день, контроль ЭКГ через 7 дней
200–300 мс (АВ-блокада I ст.)	● + Холтер 24 ч, кардиолог, ЭКГ каждые 3–5 дней
≥ 300 мс / АВ-блокада II–III ст. / ЧСС <50 / синкопе	● ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ , мониторинг, переход на в/в цефтриаксон 2 г/сут 14–21 день (риск сладжа при ЖКБ принимается как меньшее зло)

РАЗДЕЛ 9. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТОЧКИ РЕШЕНИЙ

Точка	Ожидаемое	Если НЕ так → действие
24–48 ч	Возможна «вспышка» (Яриш–Герксгеймер)	Норма. Продолжать
День 5–7 (27–29.09)	● Рост остановлен (граница не вышла за маркер). Ушла локальная гипертермия	Рост продолжается → связь с врачом, внеочередной осмотр
День 10–14 (02–06.10)	Уменьшение размера , побледнение; артралгии и одышка на убыли	● Нет динамики → биопсия края + ПЦР биоптата, консилиум, пересмотр схемы; поиск неборрелиозной причины одышки
День 21 (12.10)	Эритема значительно уменьшилась/разрешилась	Продолжающийся рост или новые очаги = неудача терапии

Точка	Ожидаемое	Если НЕ так → действие
+4 нед. после курса	Полное разрешение	Активный очаг → биопсия, консилиум

Самый чувствительный ранний маркер — локальная гипертермия. Кожа перестанет быть горячей **раньше**, чем пятно побледнеет. Это первый сигнал, что препарат работает.

Остаточная пигментация / лёгкая гиперемия после курса — НОРМА. Не является поводом для второго курса.

РАЗДЕЛ 10. ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ (зафиксировать навсегда)

Не делать	Почему
Контрольную серологию «на излеченность»	IgG сохраняются годами и десятилетиями . Положительный IgG через 3/6/12 мес — НЕ рецидив и НЕ повод для второго курса . Критерий выздоровления — только клинический
Повторные ИФА «в динамике каждые 2 недели»	Информации не даёт, создаёт ложную тревогу
ПЦР крови на боррелии	Крайне низкая чувствительность (боррелии не циркулируют в крови). ПЦР биоптата кожи — другое, оставлен в резерве
CD57-лимфоциты, тесты на «хронический Лайм»	Не валидировано, нет ни в одних рекомендациях
Иммуноблот без предшествующего ИФА	Нарушение двухэтапного алгоритма
Второй курс антибиотиков «для верности»	Не улучшает исходы, повышает риск НЯ
Люмбальная пункция «на всякий случай»	Только при неврологических находках
Профилактика КЭ / иммуноглобулин	Окно 72–96 ч упущено безвозвратно
Прерывать курс при улучшении	Недолеченность → поздние формы

РАЗДЕЛ 11. КРАСНЫЕ ФЛАГИ

11.1. 🚨 СМП / приёмный покой — немедленно

- Обморок, предобморок, **сердцебиение, перебои, «замирания»**, пульс <50
- Одышка **в покое**, ночные приступы удушья, отёки голеней
- Боль/давление за грудиной
- Сильная ГБ + рвота + светобоязнь + ригидность шеи
- Асимметрия лица, не закрывается глаз, нарушение речи
- **Крапивница по телу / отёк лица, губ, языка / затруднение дыхания** на фоне препарата
- Лихорадка + нарастающая боль в правом подреберье + желтуха / тёмная моча / светлый кал
- Высыпания стали **не бледнеющими при надавливании**, множественными, с лихорадкой

11.2. ⚠️ Внеочередной приём у инфекциониста

- **Эритема продолжает расти после 7-го дня терапии** (вышла за маркер)
- **Новые кольцевидные эритемы** на других участках тела
- **Припухлость / отёк / выпот** в голеностопе или колене → это уже артрит → пересмотр курса до 28 дней
- Утренняя скованность выросла до **30+ минут**
- Онемение, жгучие/стреляющие боли, опоясывающие боли, слабость в конечности
- Выраженная боль/жжение за грудиной при глотании (эзофагит от доксициклина)

РАЗДЕЛ 12. ДНЕВНИК САМОНАБЛЮДЕНИЯ (заполнить и принести)

12.1. Форма для заполнения — TSV (вставить в Excel)

Дата	День_курса	Доза_утро_принята	Доза_вечер_принята	Эритема_длинник_мм	Эритема_поперечник_мм	Вышла_за_маркер	Кожа_горячая	Центр_просветление	Фото_сделано	Артралгии_0_10	Утр_скованность_мин	Одышка_порог	Одышка_0_10	Температура	Новые_высыпания	Побочные_явления	Примечание
22.09.2026	1	да	да	220	110	нет	да	да	да	4	2	быстрый шаг	3	36.6	нет	нет	старт терапии, разметка
23.09.2026	2																
24.09.2026	3																
25.09.2026	4																
26.09.2026	5																
27.09.2026	6																
28.09.2026	7																
29.09.2026	8																
30.09.2026	9																
01.10.2026	10																
02.10.2026	11																
03.10.2026	12																
04.10.2026	13																
05.10.2026	14																
06.10.2026	15																
07.10.2026	16																

08.10.2026 17
 09.10.2026 18
 10.10.2026 19
 11.10.2026 20
 12.10.2026 21

Легенда полей:

- **Вышла_за_маркер** — да/нет. **Ключевое поле.** Смотреть на границу, обведённую 22.09
- **Кожа_горячая** — тыльной стороной ладони сравнить с симметричным участком другого бедра
- **Артралгии_0_10, Одышка_0_10** — субъективная шкала 0 (нет) ... 10 (максимум)
- **Одышка_порог** — при какой нагрузке появляется (покой / бытовая / быстрый шаг / этаж / нет)
- Фото — каждые 3–4 дня, один ракурс, дневной свет, **линейка в кадре**

12.2. Реестр статусов назначений — TSV

N	Исследование	Приоритет	Плановый_срок	Статус	Дата_факт
	Результат_кратко	Файл_приложен			
1	ЭКГ 12 отв. с RQ	критично	22.09.2026	не выполнено	
2	Тропонин I	критично	25.09.2026	не выполнено	
3	NT-proBNP	критично	25.09.2026	не выполнено	
4	Ферритин	критично	25.09.2026	не выполнено	
5	Железо сыворотки	критично	25.09.2026	не выполнено	
6	ОЖСС/НТЖ	критично	25.09.2026	не выполнено	
7	ТТГ	критично	25.09.2026	не выполнено	
8	ГГТП	высокий	25.09.2026	не выполнено	
9	ЩФ	высокий	25.09.2026	не выполнено	
10	Эхо-КГ	высокий	25.09.2026	не выполнено	
11	УЗИ ОБП	высокий	29.09.2026	не выполнено	
12	Иммуноблот IgG/IgM	средний	29.09.2026	не выполнено	
13	Осмотр невролога	высокий	06.10.2026	не выполнено	
14	ОАК контрольный	высокий	06.10.2026	не выполнено	
15	АЛТ/АСТ контрольные	высокий	06.10.2026	не выполнено	

РАЗДЕЛ 13. ЧЕК-ЛИСТ К СЛЕДУЮЩЕМУ ПРИЁМУ (02–06.10.2026)

Принести обязательно

- ☐ **Что**
- ☐ **Этот мастер-паспорт** (заполненные разделы 12.1 и 12.2)
- ☐ **Распечатку ЭКГ с цифрой RQ** (не заключение, а саму плёнку/распечатку)

☐ **Что**

- ☐ Все бланки анализов: тропонин, NT-proBNP, ферритин, железо, ОЖСС/НТЖ, ТТГ, ГГТП, ЩФ, ОАК, АЛТ/АСТ
- ☐ Протокол **Эхо-КГ**
- ☐ Протокол **УЗИ ОБП**
- ☐ Результат **иммуноблота** (если готов)
- ☐ Заключение **невролога** (если состоялся)
- ☐ **Все фото эритемы** по датам (телефон/распечатка), включая исходное от 22.09
- ☐ **Упаковку доксицилина** (подсчёт остатка = контроль комплаентности)

Не смывать / не стирать

| ☐ | **Разметку маркером от 22.09.2026** — обновлять контур, но **сохранять исходную линию** как точку отсчёта. Если стёрлась — восстановить по фото и подписать дату |

РАЗДЕЛ 14. ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

14.1. Требуют уточнения от пациентки

№	Вопрос	Зачем
1	Точная дата присасывания клеща (по календарю/заметкам)	Сейчас расчётная ~21.07.2026. Нужна для юридически корректной хронологии
2	Какая нога — правая или левая?	Не зафиксировано в документе
3	Когда именно появилась одышка — какая неделя после укуса?	Разделить боррелиозную и постинфекционную/железодефицитную версии
4	Был ли клещ извлечён самостоятельно или медработником? Сохранён ли? Исследовался ли?	Полнота анамнеза
5	Обращение 15–16.09 — есть ли на руках письменное заключение того инфекциониста?	Для медкарты и преемственности

14.2. Требуют решения врача на следующем приёме

№	Вопрос	Условие решения
1	Продлевать ли курс с 21 до 28 дней?	Да — если появится объективный синовит; нет — если артралгии без припухлости

№	Вопрос	Условие решения
2	Нужен ли Холтер-ЭКГ?	Да — если PQ >200 мс или одышка сохраняется к дню 14
3	Нужна ли биопсия края эритемы с ПЦР?	Да — если к дню 14 нет уменьшения размера
4	Разворачивать ли поиск неборрелиозной причины одышки?	Да — если ферритин/ТТГ/ЭКГ/Эхо чисты, а одышка не регрессирует
5	Тактика по тромбоцитозу 385 и эритроцитозу 5,51/ЦП 0,82	По результатам ферритина и контрольного ОАК
6	Тактика по ЖКБ (наблюдение / хирург)	По результатам УЗИ ОБП

РАЗДЕЛ 15. ГРАФИК НАБЛЮДЕНИЯ

Точка	Дата	Объём
Контакт (тел./онлайн)	27–29.09.2026	Рост эритемы остановлен? Гипертермия ушла? Переносимость
Очный контроль (день 10–14)	02–06.10.2026	Замер + фото эритемы, ОАК, АЛТ/АСТ, суставы, одышка, разбор всех результатов
Очный приём — завершение курса	13–15.10.2026	Итоговый замер, клиническая оценка, решение о наблюдении
Контроль	+4–6 нед. (ноябрь 2026)	Осмотр кожи, ОАК (тромбоциты), ферритин, железо, ОЖСС
Диспансерно	1 / 3 / 6 / 12 мес после курса	Осмотр; ЭКГ — при сердечных жалобах; серология НЕ сдаётся

РАЗДЕЛ 16. ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ (мастер-паспорт версий)

Шаг	Версия	Дата	Событие / основание	Что изменилось
1	v1.0	~15– 16.09.2026	Первичный приём (внешний инфекционист)	Заключение «антибиотики не нужны». Обследование не назначено
2	v1.0a	17.09.2026	Аналитический разбор, план обследования	Назначены: ИФА, иммуноблот, ЭКГ, биохимия, ОАК; зафиксировано «Спорное» по терапии
3	v1.1	22.09.2026	Получены результаты 17–22.09	IgG 1,6 (+) → диагноз верифицирован. Терапия

Шаг	Версия	Дата	Событие / основание	Что изменилось
				показана безусловно. Коинфекции исключены. Выявлены: тромбоциты 385, эритроцитоз 5,51/ЦП 0,82
4	v1.2	22.09.2026	Ответы п.6 (1–8)	Противопоказаний к доксициклину нет; Мирена не помеха. Выявлены артралгии + одышка + сыпь → эскалация , ЭКГ и Эхо-КГ в неотложный статус
5	v1.3	22.09.2026	Ответы по суставам/одышке/сыпи	Дезэскалация: артралгии без синовита → курс остаётся 21 день; кардит маловероятен (нет аритмии и СН); сыпь незначима, дерматолог снят. Приоритет ферритин/ТТГ повышен
6	v1.3a	22.09.2026	Уточнение: эритема не разрешилась, растёт (+10 %)	● Повторная эскалация. Активная инфекция в реальном времени. Введён фотопротокол и разметка. Курс 21 день зафиксирован как минимум
7	v1.4	22.09.2026	Ответы по эритеме (локализация, просветление, отсутствие валика/зуда, гипертермия, клотримазол без эффекта)	✅ Дифдиагноз ЗАКРЫТ. МЭ подтверждена клинически. Сняты: соскоб на грибы, дерматолог. Конкретизирован осмотр паховых л/у. Клотримазол отменён
8	—	22.09.2026	Аннулирован некорректный ответ (потеря контекста: шаблон первичного приёма)	Изъят из клинической логики, на решения не влияет
9	(ожидается)	02–06.10.2026	Очный контроль дня 10–14	Будет версия v1.5

РАЗДЕЛ 17. РЕЗЮМЕ НА ОДНУ СТРАНИЦУ

Пациентка 48 лет. Присасывание клеща ~21.07.2026 (внутренняя поверхность бедра). На 7-й день — мигрирующая эритема 20×10 см в месте укуса. Лечение не проводилось 9 недель. Эритема НЕ разрешилась: на 22.09.2026 — 22×11 см, продолжает расти, центр

светлее, кожа горячая, безболезненна. Клотримазол 7 дней — без эффекта. ИФА IgG 1,6 КП (+).

Диагноз: A69.2 — ИКБ, эритемная форма, ранняя диссеминированная стадия, персистирующая растущая МЭ. Артралгии голеностопов без синовита. Одышка при умеренной нагрузке — уточняется.

Терапия: доксициклин 100 мг × 2 р/сут, 21 день, 22.09 → 12.10.2026.

Три критичных задачи до следующего приёма: **1** ЭКГ с цифрой PQ — единственный незакрытый острый риск (бессимптомная АВ-блокада). **2** Фотоконтроль эритемы по маркеру — к дню 5–7 рост должен остановиться, к дню 10–14 размер должен уменьшаться. **3** Ферритин + ТТГ + тропонин/NT-proBNP — закрыть генез одышки.

Помнить: серологию «на излеченность» не сдавать никогда. IgG останется положительным на годы. Выздоровление оценивается только клинически.

Документ подготовлен: 22.09.2026 **Действителен до:** очного приёма 02–06.10.2026 (далее — версия v1.5)

Мастер-паспорт отражает клиническую логику по документально подтверждённым данным. Физикальный осмотр, разметка очага и интерпретация инструментальных исследований выполняются очно лечащим врачом. При появлении красных флагов (Раздел 11) — СМП/приёмный покой без ожидания плановой даты приёма.